ZAHTEVA ZA POJASILO IN POPRAVEK ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE

Psihiatrična bolnišnica Ormož
Prujska cesta 33, 2270 Ormož
tajnistvo@pb-ormoz.si

Zadeva: Odpustno pismo z dne 10. 9. 2026, kartica PH2601129, M.Ind: 47223
Pacient: Luka Pintarič, Štrafelova ulica 28, 2250 Ptuj
Datum: [vstavi datum]
Kraj: Ptuj

Spoštovani,

sprožam uradno zahtevo za pojasnilo in popravek zdravstvene dokumentacije, natančneje **odpustnega pisma z dne 10. 9. 2026**, katerega avtorica je zapisana Anja Šegula, dr. med., specialistka psihiatrije. Z odpustnim pismom se v celoti ne strinjam. Opozoril bi rad na šest konkretnih nepravilnosti, ki jih je treba pisno pojasniti in odpraviti. Prilagam bolj dotično opisane razloge in dejstva.

Zahtevo podajam na podlagi **Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP)**, zlasti:

- **11. člena ZPacP** (pravica do spoštovanja pacientove osebnosti in varstva človekovih pravic),
- **22. člena ZPacP** (pravica do seznanitve z zdravstvenim stanjem in načinom zdravljenja),
- **40. člena ZPacP** (pravica do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo),
- **41. člena ZPacP** (način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo — izvajalec mora pacientu omogočiti vpogled, prepis in fotokopiranje v 15 dneh od prejema zahteve).

---

1. Diagnoza F12.5 (psihotična motnja zaradi uporabe kanabinoidov) ni ustrezno utemeljena

V odpustnem pismu je edini podatek, na katerega se sklicuje diagnoza F12.5, zapis:

> *»Urin na PAS je bil THC +.«*

Pozitiven urinski test na THC dokazuje zgolj prisotnost metabolitov kanabinoidov v telesu, ne pa vzročne povezave med uživanjem kanabinoidov in morebitno psihotično motnjo.

Po diagnostičnih merilih MKB-10 za substanco povzročene psihotične motnje (F1x.5) morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. **začetek simptomov med intoksikacijo, v času odtegnitve ali v roku enega meseca po uporabi substance** — v dokumentu ni zapisano, kdaj sem nazadnje užival kanabinoide niti kdaj so se simptomi začeli;
2. **simptomi niso posledični primarni psihotični motnji** — v dokumentu sta hkrati zapisani F23.90 (primarna akutna psihotična motnja) in F12.5 (substanco povzročena), kar je notranje protislovno: ali je vzrok kanabinoidi (F12.5) ali gre za primarno motnjo (F23.90)?
3. **anamneza o času, količini in pogostnosti uporabe** — v dokumentu teh podatkov ni.

THC je v urinu dokazljiv več dni do tednov po zadnji uporabi. Pozitiven test torej ne dokazuje, da je bila uporaba sovpadala z začetkom simptomov, kar je ključno merilo za F12.5. Poleg tega raziskave kažejo, da se simptomi kanabisom povzročene psihotične motnje običajno začnejo **kmalu po uživanju ali med odtegnitvijo** — brez časovne umestitve te povezave diagnoza ne more biti postavljena.

V dokumentu teh podatkov **ni**. Diagnoza je torej postavljena izključno na podlagi enega laboratorijskega izvida, kar zdravstveno in pravno ni zadostna podlaga.

Zahtevam, da mi bolnišnica **pisno pojasni, na podlagi katerih anamnestičnih podatkov in kliničnih meril MKB-10 je bila postavljena diagnoza F12.5**.

---

2. Podpisna zdravnica ni opravila osebnega pregleda

V odpustnem pismu je podroben opis mojega sprejemnega statusa (očesni kontakt, potenje, zvok »p-p-p«, psevdofilozofiranje, afirmacija prisluhov, samomorilne misli...). Pod pismom je podpisala Anja Šegula, dr. med., ki prevzema odgovornost za vsebino.

Vendar **dr. Šegula z menoj osebno ni imela nobenega stika** — ne sprejemnega pregleda, ne pogovora, ne kakršnegakoli neposrednega opazovanja. Če je podroben opis stanja nastal na podlagi zapisov tretjih oseb (dežurni zdravnik, medicinske sestre), potem podpisna zdravnica prevzema odgovornost za opise, ki jih sama ni preverila, diagnoze pa so postavljene na podlagi posrednih informacij.

Zahtevam **pisno pojasnilo, kdo, kdaj in na podlagi kakšnega neposrednega pogovora ali pregleda je zbral anamnezo in opisal status**, ki je podlaga za diagnoze v odpustnem pismu. Prav tako zahtevam, da bolnišnica pojasni, na podlagi česa je podpisna zdravnica prevzela odgovornost za odpustno pismo, če pacienta osebno ni pregledala.

---

3. Nezadosten čas opazovanja za postavitev diagnoz

Hospitalizacija je trajala od 9. 9. 2026 do 10. 9. 2026 — torej **en dan** (en nočni spanec). Za postavitev diagnoze **F23.90 (akutna in prehodna psihotična motnja)** po MKB-10 je bistveno, da se motnja začne akutno (v roku dveh tednov) in je **prehodna** — kar po definiciji zahteva spremljanje poteka. Eno dneva opazovanja ne omogoča ugotavljanja, ali je motnja prehodna, niti ne omogoča zanesljivega izključevanja drugih vzrokov.

Prav tako en dan ne zadošča za **diferencialno-diagnostični postopek**, ki bi ločil med:

- F23.90 (primarna akutna psihotična motnja),
- F12.5 (substanco povzročena psihotična motnja),
- organsko pogojeno psihotično motnjo (glej točko 4 — priporočilo MR glave).

Da sta hkrati zapisani F23.90 in F12.5, pomeni, da diferencialna diagnoza **ni bila zaključena**, ampak sta obe diagnozi navedeni vzporedno, brez pojasnila, katera je primarna in na podlagi česa.

Zahtevam pojasnilo, kako je bila opravljena diferencialna diagnoza in kako je bilo v enem dnevu izključeno, da gre za organsko pogojeno ali primarno psihotično motnjo.

---

4. Notranja protislovnost glede zaznavnih motenj

V povzetku zdravljenja sta zapisana hkrati:

> *»afirmiral je občasne prisluhe«*

in takoj za tem:

> *»ni deloval pod vplivom zaznavnih motenj.«*

Trditev, da sem potrjeval prisluhe, opisuje zaznavno motnjo. Formula, da »ni deloval pod vplivom zaznavnih motenj«, je nejasna in notranje protislovna. Če so prisluhe prisotne, gre za zaznavno motnjo — ne glede na to, ali je pacient pod njenim »vplivom« ali ne. Ker se prisluhe navajajo kot podlaga za diagnozo F23.90, bi morala biti ta formulacija jasno pojasnjena.

Zahtevam pojasnilo, kaj natančno pomeni »ni deloval pod vplivom zaznavnih motenj« in kako to sovpada z zapisom, da sem afirmiral prisluhe.

---

5. Priporočilo MR glave nakazuje nerazjasnjeno diferencialno diagnozo

Odpustno pismo priporoča **MR glave**. Če obstaja sum na organsko vzročnost (struktura, vnetje, druga nevrološka bolezen), to potrjuje, da vzrok epizode **ni bil zadostno razjasnjen** — in s tem neposredno oslabi tezo, da gre za substanco povzročeno motnjo (F12.5). Prisotnost sumu na organski vzrok namreč pomeni, da diferencialna diagnoza še teče, kar je v nasprotju s postavitvijo končne diagnoze F12.5 in F23.90.

Zahtevam pojasnilo, kakšna je klinična indikacija za MR glave, katere organske vzroke sumite in kako to sovpada z diagnozama F12.5 in F23.90.

---

6. Predpis zdravil, ki vsebujejo laktozo, kljub zapisani laktozni intoleranci v kartoteki

V moji kartoteki je zapisana laktozna intoleranca. Kljub temu sta mi bili predpisani dve zdravili, ki **obse vsebujeta laktozo**:

- **Zyprexa 20 mg** (olanzapin) — vsebuje **238 mg laktoze monohidrata na tableto**. Po lastnem povzetku lastnosti zdravila (EMA / EU register) velja izrecno opozorilo: *"Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila."*
- **Mirzaten 30 mg** (mirtazapin) — vsebuje **laktozo monohidrat** kot pomožno snov z znanim učinkom (CBZ Slovenija, povzetek glavnih značilnosti).

Skupni dnevni vnos laktoze iz predpisane terapije je torej neznanemanljiv in klinično relevanten, zlasti pri pacientu z dokumentirano intoleranco. Na voljo so laktosno ne vsebujoče alternative (glej prilogo), vključno z antidepresivi v obliki tablet brez laktoze (npr. sertralin/Asentra, escitalopram/Cipralex) in antipsihotiki v tekoči obliki (npr. aripiprazol oralna raztopina).

Predpis obeh zdravil brez preverjanja intolerance in brez obravnavanja laktosno ne vsebujočih alternativ je jasen spregled, ki je v nasprotju z načelom varne in strokovno utemeljene zdravstvene oskrbe (22. člen ZPacP).

Zahtevam pojasnilo, zakaj ni bila upoštevana zapisana laktozna intoleranca in zakaj nista bili izbrani laktosno ne vsebujoči alternativi.

Zahtevam naslednje:

1. **Pisno pojasnilo**, na podlagi katerih anamnestičnih podatkov in kliničnih meril MKB-10 je bila postavljena diagnoza F12.5, zlasti glede časovne umestitve med uživanjem kanabinoidov in začetkom simptomov;
2. **Pisno pojasnilo**, kdo je osebno opravil sprejemni pregled in na podlagi česa je podpisna zdravnica opisala stanje;
3. **Pisno pojasnilo**, kako je bila opravljena diferencialna diagnoza med F23.90, F12.5 in organsko pogojeno motnjo v enem dnevu hospitalizacije;
4. **Pisno pojasnilo** o indikaciji za MR glave, katere organske vzroke sumite in kako to sovpada z diagnozama F12.5 in F23.90;
5. **Pisno pojasnilo**, zakaj sta bili predpisani zdravili z laktozo kljub zapisani intoleranci v kartoteki;
6. **Popravek ali dopolnitev odpustnega pisma**, če se ugotovi, da diagnoza F12.5 ni bila ustrezno utemeljena ali da predpis zdravil z laktozo ni bil ustrezen;
7. **Vpogled v celotno zdravstveno dokumentacijo** (zapisniki sprejema, zdravniški zapisi, laboratorijski izvidi, sodni spis Pr 50/2026) v skladu z **40. in 41. členom ZPacP**, in sicer v roku 15 dni od prejema te zahteve.

Prosim, da mi odgovorite **v roku 30 dni od prejema tega pisma**. V kolikor ne bom prejel zadovoljivega pojasnila, bom vložil pritožbo na vodstvo bolnišnice ter pri **Zavodu RS za varstvo pravic pacientov** in **Ministrstvu za zdravje**.

S spoštovanjem,

Luka Pintarič
Štrafelova ulica 28, 2250 Ptuj
[telefon, e-naslov]

PRILOGA: Alternative brez laktoze (za pogovor z zdravnikom)

> ⚠️ **Pomembno:** To ni medicinski nasvet. Te podatke prineseš s seboj na kontrolo in z njimi odpreš pogovor z zdravnikom. **Ne prekini ali zamenjaj zdravil samostojno** — prekinitev antipsihotika/antidepresiva je lahko nevarna (odtegnitveni simptomi, rebound psihotična epizoda).

Antidepresiv — alternativa za Mirzaten (mirtazapin), BREZ laktoze

Zdravilo (učinkovina)	Tržno ime	Pomožne snovi	Laktoza?
Sertralin	Asentra	kalcijev hidrogenfosfat, mikrokristalna celuloza, natrijev karboksimetilni škrob, smukec, magnezijev stearat	**BREZ laktoze** ✅
Escitalopram	Cipralex	silicificirana mikrokristalna celuloza, smukec, premrežen natrijev karmelozat, magnezijev stearat	**BREZ laktoze** ✅
Fluoksetin	Prozac	škrob, želatina, mikrokristalna celuloza	**BREZ laktoze** ✅

Vir: povzetki glavnih značilnosti zdravil (EMA, CBZ Slovenija, Moja-lekarna).

Antipsihotik — alternativa za Zyprexa (olanzapin), BREZ laktoze

Zdravilo (učinkovina)	Oblika	Laktoza?	Opomba
Aripiprazol	oralna raztopina (tekočina)	**BREZ laktoze** ✅	Tekoča oblika ne vsebuje laktoze kot polnila
Haloperidol	oralna raztopina (tekočina)	**BREZ laktoze** ✅	Vsebuje laktat (ne laktozo)

> ⚠️ Pozor: tablete aripiprazola (Abilify), kvetiapina (Seroquel), risperidona in haloperidola **vse** vsebujejo laktozo monohidrat. Laktosno ne vsebujoče alternative za antipsihotike so predvsem **tekoče (oralne) oblike**. O tem se je potrebno posvetovati z zdravnikom in farmacevtom.

Koraki, ki jih lahko storiš

1. **Pošlji zgornje pismo** na tajnistvo@pb-ormoz.si (ali po pošti) — pridobi potrdilo o prejemu.
2. **Zahtevaj vpogled v celotno kartoteko** (zdravniški zapisi, zapisnik sprejema, laboratorijski izvidi, sodni spis Pr 50/2026) — pravica po ZDRA-1.
3. **Kontaktiraj osebnega zdravnika ali farmacevta** v zvezi z laktozno intoleranco in alternativami. Če imaš simptome (napenjanje, driska, krči), to dokumentiraj.
4. **Na kontroli 25. 11. 2026 (11:40, CAFUTA)** izpostavi vseh pet točk.
5. **Ne prekini zdravil samostojno.** Morebitna zamenjava naj poteka postopoma pod nadzorom zdravnika.
6. Če bolnišnica ne odgovori v 30 dneh ali odgovor ni zadovoljiv → **pritožba na vodstvo bolnišnice** in/ali **Zavod RS za varstvo pravic pacientov**.